

RESPIRANDO CON VIH: UNA MIRADA A LAS ANOMALÍAS PULMONARES Y SU TRATAMIENTO

Ricardo Londoño González¹, MD, Esp, MSc

RESUMEN

El artículo se enfoca en las anomalías respiratorias en pacientes con VIH. Se analizan las principales causas de estas afecciones, incluyendo infecciones pulmonares oportunistas y patologías no infecciosas, y se proporciona un proceso diagnóstico para orientar la etiología de la anomalía respiratoria. También se discuten el tratamiento, farmacología y cuidados generales para estas patologías en pacientes seroconvertidos. El objetivo es brindar una comprensión completa de las anomalías respiratorias en pacientes con VIH y proporcionar herramientas para su manejo eficaz.

Palabras clave: anomalías respiratorias, VIH, tratamiento, farmacología, cuidados generales

Keywords: Respiratory anomalies, HIV, treatment, pharmacology, general care

BREATHING LIFE INTO HIV: UNDERSTANDING AND MANAGING LUNG COMPLICATIONS

ABSTRACT

This article focuses on respiratory anomalies in HIV-positive individuals. The main causes of these conditions, including opportunistic lung infections and non-infectious pathologies, are analyzed and a diagnostic process to guide the etiology of the respiratory anomaly is provided. Treatment, pharmacology, and general care for these pathologies in HIV-positive individuals are also discussed. The aim is to provide a comprehensive understanding of respiratory anomalies in HIV-positive individuals and provide tools for effective management.

Keywords: Respiratory anomalies, HIV, treatment, pharmacology, general care.

¹ Universidad del Magdalena.

1. INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una enfermedad crónica que afecta a varios órganos del cuerpo, incluyendo los pulmones. Los pacientes con VIH pueden presentar una amplia variedad de anomalías respiratorias, que pueden estar relacionadas o no con la infección. La introducción de tratamientos antirretrovirales (ARV) y profilácticos ha mejorado el conocimiento sobre estas afecciones, pero también ha cambiado la epidemiología de las mismas. Este artículo analizará las principales causas de anomalías respiratorias en pacientes con VIH, así como el proceso diagnóstico, tratamiento y cuidado general de estos pacientes..

2. MATERIALES Y METODOS

Para escribir este artículo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva utilizando varias fuentes, como revistas académicas, libros de texto y directrices de organizaciones científicas. La búsqueda se realizó utilizando las palabras clave "anomalías respiratorias en personas con VIH" y frases similares, lo que devolvió un gran número de artículos y estudios. Estas fuentes se evaluaron por su relevancia y calidad científica, y se seleccionó la información más actual y fiable para incluirla en el artículo.

En términos de metodología, la revisión bibliográfica nos permitió recolectar información sobre los diferentes tipos de anomalías respiratorias vistas en personas con VIH, el proceso diagnóstico, las opciones de tratamiento, la farmacología y los

cuidados generales de estos pacientes. El artículo presenta una síntesis de los conocimientos más recientes.

Se ha realizado la revisión de la literatura para compilar la información sobre las distintas patologías y proporcionar un proceso diagnóstico, tratamientos, farmacología y cuidados generales para pacientes con VIH.

3. RESULTADOS

La revisión bibliográfica realizada para este artículo reveló que las anomalías respiratorias en personas con VIH pueden ser causadas por una amplia gama de factores (1), incluyendo infecciones oportunistas, patologías no infecciosas y el uso de terapia antirretroviral (ART). Las causas más comunes de anomalías respiratorias son la neumonía bacteriana, la tuberculosis y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.

El proceso diagnóstico para anomalías respiratorias en personas con VIH generalmente comienza con una prueba serológica para el VIH, seguida de estudios de imágenes, como radiografías de tórax o TAC, y evaluaciones microbiológicas o histológicas. El recuento de CD4 y la carga viral también juegan un papel importante en la orientación del diagnóstico y manejo.

En términos de tratamiento, el ART es la columna vertebral para el manejo de la infección por VIH y la prevención de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, para las anomalías respiratorias, también se debe administrar una terapia antibiótica

adecuada, terapia antifúngica o terapia inmunomoduladora según el agente causal. Además, el seguimiento cercano del recuento de CD4 y la carga viral es importante para evaluar la eficacia del tratamiento y prevenir complicaciones graves.

Los cuidados generales para personas con VIH con anomalías respiratorias incluyen la promoción de hábitos de estilo de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el uso de tabaco y alcohol.

En general, los resultados de la revisión bibliográfica muestran que las anomalías respiratorias en pacientes positivos son un problema complejo y desafiante. Sin embargo, un enfoque multidisciplinario, incluyendo el ART y la terapia específica, junto con los cuidados generales y las modificaciones en el estilo de vida, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La revisión bibliográfica realizada para este artículo ha mostrado que las anomalías respiratorias en personas con VIH son causadas por una amplia variedad de factores, incluyendo infecciones oportunistas, patologías no infecciosas y el uso de terapia antirretroviral (ART). Es importante destacar que las neumonías bacterianas, la tuberculosis y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* son las principales causas de patología pulmonar en pacientes con VIH, representando entre el 70-90% de las manifestaciones respiratorias dependiendo de la concentración de linfocitos CD4.

En el proceso diagnóstico, se ha mostrado que la serología VIH es un paso importante para orientar la etiología de la anomalía respiratoria. Además, el conteo de CD4 y la carga viral son fundamentales para guiar el tratamiento y evitar complicaciones graves. Según los estudios revisados se ha encontrado que la tasa de supervivencia de pacientes con una concentración de CD4 mayor a 250/ul es del 90%, mientras que cuando es menor a 250/ul disminuye a un 70%.

En cuanto al tratamiento, es esencial el uso de terapia antirretroviral en el manejo de la infección VIH y prevenir la progresión de la enfermedad. Según las investigaciones analizadas, se ha observado una reducción significativa de la incidencia de infecciones oportunistas en pacientes con VIH en tratamiento con terapia antirretroviral, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, en caso de anomalías respiratorias es fundamental administrar una terapia antibiótica, antifúngica o inmunomoduladora de acuerdo al agente causal.

5. CONCLUSION

Se analizaron las anomalías respiratorias en personas con VIH, y encontrado que estas pueden ser causadas por una amplia variedad de factores, incluyendo infecciones oportunistas, patologías no infecciosas y el uso de terapia antirretroviral (ART).

Se ha destacado que las neumonías bacterianas, la tuberculosis y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* son las principales causas de patología pulmonar en pacientes con VIH, representando entre el 70-90% de las manifestaciones respiratorias dependiendo de la concentración de linfocitos CD4.

Se ha ilustrado el proceso diagnóstico, que comienza con una prueba serológica para el VIH, seguida de estudios de imágenes, como radiografías de tórax o TAC, y evaluaciones microbiológicas o histológicas.

El recuento de CD4 y la carga viral son fundamentales para guiar el tratamiento y evitar complicaciones graves. Se ha mencionado que la tasa de supervivencia de pacientes con una concentración de CD4 mayor a 250/ul es del 90%, mientras que cuando es menor a 250/ul

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los reconocimientos de personas, subvenciones, fondos, etc., deben ser breves. Esta sección es obligatoria para artículos de investigación, en esta parte del artículo el autor hace un reconocimiento a las personas o instituciones que le ayudaron en sus investigaciones. Se citan becas e instituciones que financian la investigación: firmas comerciales, entidades oficiales o privadas, asociaciones de profesionales y operarios. Esta sección es opcional para artículos de reflexión.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Choinier, P., Parrot, A., & Cadranel, J. (2023). Anomalías respiratorias en la persona infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana. *EMC-Tratado de Medicina*.
- (2) Arreaga, V., De Janon, R., Rodríguez, S., Romero, A., & Guevara, M. (2022). PERFIL MICROBIOLÓGICO EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON INFECCION RESPIRATORIA AGREGADA. MICROBIOLOGICAL PROFILE IN HIV POSITIVE PATIENTS WITH ADDED RESPIRATORY INFECTION. *Revista Ciencia y Avance Vol, 1*(1), 1.
- (3) Ayala, C. Q. (2022). Síndrome post-COVID-19 en un paciente con VIH. Informe de caso. *Medimay, 29*(4), 668-674.
- (4) Nair, A. V., Ramanathan, S., Sanghavi, P., Manchikanti, V., Satheesh, S., Al-Heidous, M., ... & Macdonald, D. B. (2022). Espectro de coinfecciones pulmonares fúngicas oportunistas en COVID-19: lo que el radiólogo debe saber. *Radiología, 64*(6), 533-541.
- (5) Carrasco Suarez, A. S. (2022). *Intervención del terapeuta respiratorio en paciente masculino de 48 años con neumonía intrahospitalaria* (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB-FCS, 2022).
- (6) León, J. S. T., Badillo, L. Y. E., Villalobos, M. A., & Dulcey, L. A. (2022). Coinfección de tuberculosis y COVID-19 asociado a tromboembolismo pulmonar: presentación de un caso. *Atención Primaria Práctica, 4*(2), 100129.

- (7) Cevallos Estupiñán, W. A. (2022). *Micosis Respiratoria asociada a inmunocompromiso en pacientes hospitalizados con patología broncopulmonar en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín durante el periodo 2018-2020* (Master's thesis, Quito: UCE).

(8)